



Carta Institucional de Orientação e Segurança Assistencial

Performa Saúde

As orientações deste documento foram elaboradas com base em eventos assistenciais recentes e nas análises conduzidas pela Gestão da Qualidade, em conjunto com a Coordenação Médica da Performa Saúde.

Nosso propósito é reforçar a segurança assistencial, padronizar as condutas médicas e assegurar o cumprimento das normas éticas que regem a prática profissional. Reforçamos, ainda, a importância de que todo atendimento ao paciente siga rigorosamente os protocolos institucionais padronizados do Hospital M'Boi Mirim, garantindo qualidade, uniformidade e segurança em cada etapa do cuidado.



Segurança Assistencial

Reforçar a segurança e qualidade do cuidado ao paciente.



Padronização de Condutas

Estabelecer diretrizes claras para a prática médica.



Cumprimento das Normas Éticas

Assegurar a aderência aos princípios éticos da profissão.

Essas diretrizes refletem o compromisso institucional da Performa Saúde com a qualidade, a ética e a segurança do paciente, fundamentadas em evidências científicas e nas melhores práticas clínicas.

Em caso de dúvidas ou divergências de conduta, entre em contato com o setor de Qualidade ou Coordenação Médica Performa Saúde, para registro e análise.

Hedine Aparecida Mendes da Costa

Gestão da Qualidade – *Performa Saúde*

✉ hedine@performasaude.com.br

Meta Internacional de Segurança nº 3 – Uso Seguro de Medicamentos: Ceftriaxona e Lidocaína

Lidocaína - Via Intramuscular

Utilizar exclusivamente via **intramuscular (IM)**, concentração **1% ou 2% sem vasoconstritor**. O uso por via intravenosa direta é **estritamente proibido** conforme diretrizes da ANVISA, FDA e literatura médica internacional.

Ceftriaxona - Diluição Adequada

Para administração endovenosa, utilizar **apenas água destilada ou soro fisiológico 0,9%**. Nunca associar lidocaína para diluição EV.

Referências: ANVISA, FDA, Infarmed Portugal, MSF Guidelines, Roche (2024)

Meta Internacional de Segurança nº 3 – Uso Seguro de Medicamentos: Uso Correto da Lidocaína e Morfina em Infusão Contínua

Lidocaína EV

Proibido uso direto endovenoso. Quando prescrita, utilizar exclusivamente em **bomba de infusão contínua (BIC)** a 1 mg/min com monitorização cardíaca rigorosa. Necessita validação prévia da farmácia clínica.

Ref: Goodman & Gilman (2022); British Pain Society (2018)

Morfina EV

Sempre em **BIC**, nunca em dose direta. **Exemplo correto:** Morfina 10 mg/mL – 6 mg diluída em 100 mL SF, infusão 4,2 mg/h (24h). Descrever detalhadamente diluição e taxa na prescrição.

Ref: WHO (2012), SOBRATI (2021), CFM nº 1.638/2002

Conduatas em Pacientes Psiquiátricos

⚠️ Protocolo Obrigatório

Seguir **sempre** a conduta estabelecida pelo psiquiatra responsável pelo paciente. Qualquer necessidade de ajuste de dose ou modificação terapêutica deve ser previamente comunicada ao especialista e devidamente registrada no prontuário médico, com justificativa clínica detalhada. A interconsulta é fundamental para garantir a continuidade e segurança do tratamento psiquiátrico.

Base: Código de Ética Médica (arts. 1º, 11, 87); RDC 36/2013 (ANVISA)

Obrigatoriedade da Evolução Médica



Registro no Prontuário Médico

O prontuário médico é um **documento legal e ético de caráter obrigatório**. Todo atendimento, conduta terapêutica e alta hospitalar devem ser devidamente registrados, garantindo a **continuidade assistencial**, a **segurança do paciente** e a **segurança jurídica** do profissional e da instituição.



Registro do Atendimento

Registrar de forma completa a **anamnese**, o **exame físico** e as **hipóteses diagnósticas**, assegurando clareza e rastreabilidade das informações clínicas.



Conduta Terapêutica

Descrever o **tratamento instituído**, as **condutas adotadas** e suas **justificativas clínicas**. Todo **paciente internado pela porta de entrada PSA** deve conter uma **avaliação médica de admissão**, além de **reavaliações obrigatórias em 6 horas e 12 horas após a internação**, documentadas em evolução médica.

É obrigatório que **todo atendimento realizado pelo médico** seja da porta ou na emergência — incluindo **procedimentos** e **condutas adotadas** — esteja devidamente **evoluído e registrado** no prontuário. A ausência de evolução médica configura **falha assistencial** e pode representar **risco à segurança do próprio profissional**, além de comprometer a continuidade do cuidado.



Evolução e Desfecho

Registrar a **resposta terapêutica**, as **condições clínicas de alta** e as **orientações fornecidas ao paciente e/ou familiares**, assegurando integralidade e rastreabilidade do cuidado prestado.



Base Legal:

- Resolução CFM nº 1.638/2002
- Código de Ética Médica (arts. 87 e 88)
- Lei nº 8.080/1990

Extubação de Pacientes



Procedimento Médico

A **extubação** é um **ato médico** que deve seguir critérios clínicos definidos e ser realizada de forma **segura e colaborativa**. Embora a decisão seja médica, extubar é mais do que retirar um tubo — é **agir com técnica, prudência e integração de saberes**, assegurando cuidado contínuo e seguro.



Alinhamento Multidisciplinar

Trata-se de um **processo multiprofissional**, que exige **alinhamento prévio com a equipe de fisioterapia e enfermagem**, garantindo preparo adequado e segurança ao paciente. Antes do procedimento, é essencial comunicar e planejar a extubação com a equipe, avaliando conjuntamente as **condições clínicas, hemodinâmicas e ventilatórias**. A ausência de alinhamento multiprofissional representa **risco à segurança do paciente** e pode implicar em **responsabilidade ética e assistencial**.



Documentação Completa

Após a realização, o médico deve registrar no **prontuário** as condições **pré e pós-extubação**, incluindo parâmetros observados e profissionais envolvidos.

 **Base Técnica:** RDC nº 36/2013 (ANVISA); Resolução CFM nº 1.638/2002; Código de Ética Médica (arts. 87 e 88)

Pontualidade e Início dos Plantões

1 Antecedência Obrigatória

Chegar com **15 minutos de antecedência** ao horário de início do plantão para realizar adequadamente a passagem de plantão com a equipe anterior.

2 Comunicação de Atrasos

Eventuais atrasos devem ser **justificados imediatamente** à coordenação médica, antes do horário previsto de início das atividades.

A pontualidade garante a continuidade assistencial, a segurança do paciente e demonstra compromisso profissional com a equipe e a instituição.

Base: Código de Ética Médica (arts. 18 e 19), Política de Recursos Humanos – Performa Saúde (2025)